DATO DE ATENCIÓN URGENCIA (DAU)

ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL SAN CARLOS	N°DAU	3719808
CALIDAD	Original	FECHA	27/07/2024 16:20
AREA	U.E. Adulto	BOX	4
HC	0	CTA. CTE.	0

DATOS CONSULTANTE:

Nombre : LIDIA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ **RUN** : 6.950.004-8 **CP** : 602074
Previsión : FONASA B **F.Nac** : 03/10/1943 **Género** : Femenino **Edad** : 80 Años 9 Meses 24 Días
Dirección : Cachapoal **Comuna** : SAN CARLOS **Teléfono** : 93691094

DATOS INGRESO:

Procedencia : TERESA BALDECHI (CESFAM) **Mot. Consulta** : MORBILIDAD COMUN
Lug. Ocurrencia : NO_ESPECIFICADO **Med. Llegada** : AMBULANCIA SAPU CESFAM

SELECTOR DEMANDA: 1° llamado: 27/07/2024 16:40:45;

Profesional : Maritza Yasmin Biernay Morales **Hra. Llamada** : 27/07/2024 16:40 **Hora Atención** : 27/07/2024 16:46
T° Axilar : 0 **T° Rectal** : **Presión** : **Pulso** : 86 **Frec. Resp.** : 43
Saturometría : 97 **HGT** : **Peso** : **Glasgow** : **Clasificación** : C2
Motivo de consulta: : ADULTO MAYOR DERIVADA DESDE APS T. BALDECHI
INGRESA ACOMPAÑADA POR HIJA
AM: FIBROSIS PULMONAR - TAQUICARDIA PAROXISTICA- HIPOTIROIDISMO
ALERGIAS: NO
SAT: 97% CON FIO 2 32% FC: 86 LPM FR: 43 POR MINUTO

CONTROL SIGNOS VITALES:

Fecha	Pulso	Presión	T° Axilar	T° Rectal	FR	Sat.	HGT	Profesional
27/07/2024 17:26	92	118/82			35	100		SCARLETT NICOLE FUENTES MONROY
27/07/2024 19:05	92	111/71	36.3			96		SCARLETT NICOLE FUENTES MONROY
27/07/2024 21:26	76	113/72	36.5			96	325	STEPHANIE CAROLINA MARABOLÍ ALMARZA
27/07/2024 21:51							374	Viviana Sanchez Zuñiga
27/07/2024 21:57	81	111/74	36.2			95		Viviana Sanchez Zuñiga

ACCIDENTE, ALCOHOLEMIA Y/O TOXICOLOGIA:

INFORME LESIONES : NO **INFORME ALCOHOLEMIA:** : NO

ANAMNESIS:

Fecha	Anamnesis	Profesional
27/07/2024 17:03	AM: Fibrosis pulomnar, TPSV, Hipotiroidismo, HTA, Artrosis, usuaria de O2 domiciliario de manera intermitente RAM: Niega Paciente derivada desde CESFAM Teresa Baldecchi por sospecha de NAC. Refiere inicio de sintomatología hace 10 días, caracterizada por exacerbacion de tos basal, dorsalgia y disnea de esfuerzo. Consultó en extrasistema donde se indico tratamiento con Amoxi/Ac. Clavulanico, que termino hace 2 días sin remision del cuadro. Al interrogatorio niega fiebre y otros sintomas asociados. Ingresa HD estable, taquipneica, saturando 97% apoyada con 1 lt por NRC.	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO
27/07/2024 18:39	Ex de laboratorio Glicemia 117 Creatinina 0.9 PCR 60.9 Uremia 34 ELP 132/6/97 Hb 13.2 Leucocitos 12500 Plaquetas 516 GSA pH 7.43 pCO2 29.1 HCO3 19.6 pO2 168.2	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO

EXAMEN FÍSICO :

Fecha	Examen Físico	Profesional
27/07/2024 17:03	Vigil, cooperadora Piel y mucosas hidratadas, llene capilar <2 seg MP (+) sibilancias espiratorias, estertores difusos en ambos campos pulmonares RR2T NAS EEII sin edema ni signos de TVP	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO

DIAGNÓSTICOS: **Condición de ingreso:** Conciente

Fecha	Hipótesis diagnóstica	Profesional
27/07/2024 19:33	Fibrosis pulmonar	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO
27/07/2024 19:33	J96.9 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO EN BOX):

Fecha	Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos	Profesional	Estado	Responsable
27/07/2024 17:03	NBZ berodual 1:3 c/15 min x 3 veces	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO	Ejecutado el 27/07/2024 18:06	SCARLETT NICOLE FUENTES MONROY
27/07/2024 17:03	KNT R	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO	Ejecutado el 27/07/2024 19:00	Camila Llanos Morales
27/07/2024 17:03	Ex de laboratorio	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO	Ejecutado el 27/07/2024 17:47	Camila Llanos Morales
27/07/2024 17:03	TC de torax s/c	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO	Ejecutado el 27/07/2024 19:15	Fabiola Palma Hernandez Obs:TOMADA PENDIENTE INFORME
27/07/2024 17:03	Hidrocortisona 100 mg EV	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO	Ejecutado el 27/07/2024 17:47	Camila Llanos Morales
27/07/2024 18:42	SG al 10% 500cc + 10UI IC a pasar en 1 hr	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO	Ejecutado el 27/07/2024 19:01	Francisco Parada Riquelme
27/07/2024 19:29	Ceftriaxona 2 gr EV	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO	Ejecutado el 27/07/2024 20:05	LORENA VASQUEZ ORTEGA
27/07/2024 19:30	Hospitalizar en HODOM	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO	Ejecutado el 27/07/2024 20:05	LORENA VASQUEZ ORTEGA Obs:coordinado por dr Sanchez

EXAMENES:

Fecha	Examen	Profesional
27/07/2024 17:04	VHS ; RCTO GLOBULAR ; GLICEMIA ; UREMIA ; CREATININEMIA ; E.L.P. ; PCR ; GASES ARTERIALES ;	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO
27/07/2024 17:04	TC T?RAX ALTA RESOLUCI?N SIN CONTRASTE	Giovanni Alejandro Sánchez Troncoso

INDICACIONES ALTA:

Fecha	Indicación	Profesional
27/07/2024 19:33	Regimen comun a tolerancia Reposo relativo, levantarse asistida Ceftriaxona 2 gr/día EV por 7 días (1/6)	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO

Paracetamol 500 mg, 2 c/8 hrs por 5 días VO
Ibuprofeno 400 mg, 1 c/8 hrs por 4 días VO
B. de ipratropio 2 puff c/6 hrs por AEC
Salbutamol 2 puff c/4 hrs por AEC
Prednisona 20 mg c/12 hrs por 3 días
KNT R
Control con examenes lunes 29/07/2024
Pendiente rescatar informe de TC de torax
Urgencias SOS

RECETAS:

Fecha	Prescripción	Profesional
27/07/2024 20:46	Ceftriaxona 2 gr/día EV por 6 días Paracetamol 500 mg, 2 c/8 hrs por 5 días VO Ibuprofeno 400 mg, 1 c/8 hrs por 4 días VO B. de ipratropio 2 puff c/6 hrs por AEC Salbutamol 2 puff c/4 hrs por AEC Prednisona 20 mg c/12 hrs por 3 días	GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO

OBSERVACIONES:

Fecha	Indicación	Profesional
27/07/2024 17:27	pcte SAT: 99/100% con 1 lto por nrc, se inicia primer nebulización a las 17:20 Hrs.	SCARLETT NICOLE FUENTES MONROY
27/07/2024 17:46	Usuaria de 80 años semi-dependiente con antecedentes de fibrosis pulmonar (usuaria de o2 domiciliario SOS), taquicardia paroxistica, hipotirodismo, artrosis, sin alergias conocidas. Derivada desde APS T. Baldechi por obs. NAC, acompañada de su hija quien refiere cuadro de tos productiva, dorsalgia y disnea de 2 semanas de evolucion, refiere haber consultado en extrasistema y haber completado 7 dias de tratamiento antibiotico (Amoxi/Ac. Clavulanico) persistiendo con sintomas. Al ingreso en RCG, glasgow 14 puntos 4+4+6, desorientada en tiempo. Al CSV normocardica, normotensa, normosaturando con o2 NRC 3 lt, taquipneica. Al examen fisico destaca yug. ingurgitadas, torax simetrico, tos +, disneica en reposo, dorsalgia +. Instalo VVP 16 ESD, se toman exs + GSA con FiO2 24%.	Camila Llanos Morales
27/07/2024 18:44	KNT Usuaria en BEG, acompañada por su hija, vigil, colaboradora, apoyada con 1 L por nrc, disneica a mínimos esfuerzos, con frémitos palpables (+) y polipneica. Fc:84lpm SpO2: 94 % Mp(+) disminuido en bases con crepitos gruesos y sibilancias espiratorias bilateral de predominio basal. Realizo Ek + ktr Ktr: ttkk db + tos dirigida, moviliza abundate sb mucopurulenta que expectora. Finalizo sin incidentes. Klgo Francisco Soto O.	NATALIA ABIGAIL INOSTROZA ORTEGA
27/07/2024 19:16	TAC TOMADO	Fabiola Palma Hernandez
27/07/2024 21:53	TC de Tórax Hallazgos: Enfermedad pulmonar intersticial difusa fibrótica, sin patrón de UIP. Ateromatosis coronaria y aórtica. Leve derrame pericárdico.	Viviana Sanchez Zuñiga

GES : No **PERTINENCIA** : Si **DESTINO** : Hospital APS

ADVERTENCIA
ESTE ES UN DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y SÓLO UNA PRIMERA ATENCIÓN. DEBE CONSULTAR A SU CENTRO DE SALUD O MÉDICO TRATANTE DENTRO DE LAS 12-24 HORAS SIGUIENTES. SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, CONSULTE NUEVAMENTE A LA BREVEDAD. ES SU RESPONSABILIDAD SEGUIR ESTAS INDICACIONES.

LLAME A SALUD RESPONDE
600·360·7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

www.hospitalsancarlos.cl
Fono: +56 42 2586130

ORIGINAL: PACIENTE
4445105211158

GIOVANNI ALEJANDRO SÁNCHEZ TRONCOSO
19.823.365-K